



MANEJO DA
**DOR CRÔNICA
NA APS**

Comunicação Efetiva e Empática na Atenção Primária:

fortalecendo a relação com o paciente
para um cuidado mais humano e eficaz.



Ajuste a tela para leitura horizontal.



Baixe e imprima este
material em formato A4.





Apresentação

A comunicação na Atenção Primária à Saúde (APS) vai além da simples transmissão de informações. A comunicação eficiente entre terapeuta e paciente constitui a base para a construção da confiança entre profissionais de saúde e usuários, influenciando diretamente a forma como os pacientes se sentem ao acessar a porta de entrada do sistema de saúde. No contexto das condições crônicas, como a dor persistente, a comunicação efetiva, componente-chave do cuidado centrado no paciente, desempenha papel essencial na adesão ao tratamento e na obtenção de melhores desfechos clínicos.

O cuidado centrado no paciente é uma abordagem essencial e abrangente da atenção em saúde que coloca as necessidades, valores e preferências do indivíduo como guias principais de todas as decisões clínicas. É definido como o cuidado que respeita e responde às especificidades de cada paciente, garantindo que suas preferências orientem a conduta terapêutica (Guan, 2011). Os principais componentes desse modelo incluem: o respeito e a dignidade, traduzidos pelo reconhecimento dos valores individuais do paciente e de sua família; a comunicação efetiva e transparente, com compartilhamento contínuo de informações; a participação ativa do paciente nas decisões

sobre seu cuidado, com estímulo à autonomia e corresponsabilização (Silva *et al.*, 2019); a visão integral da pessoa, que contempla não apenas os sintomas físicos, mas também os aspectos emocionais, sociais e espirituais (Cliff, 2012); e, por fim, a garantia de continuidade e coordenação do cuidado, assegurando a integração dos serviços ao longo do tempo e entre os níveis de atenção (Stewart, 2001). Essa perspectiva fortalece a humanização do atendimento e promove vínculos mais efetivos entre profissionais e usuários do sistema de saúde.

Como a dor crônica é um problema de saúde mundial, recomendações internacionais, como a diretriz NG193 para dores crônicas primárias e secundárias, publicada pelo *National Institute for Health and Care Excellence* (NICE), no Reino Unido, estabelece recomendações baseadas em evidências para a avaliação de todos os tipos de dor crônica (primária, secundária ou ambas) e para o manejo específico da dor crônica primária em pessoas com 16 anos ou mais. Entre os princípios orientadores na NG193, destaca-se a ênfase na comunicação centrada no paciente, que valoriza o direito à escuta qualificada, o respeito às preferências individuais e a participação ativa na tomada de decisões sobre o cuidado (Nice, 2021).



Apresentação

O Reino Unido apresenta, ainda, diretrizes sobre a qualidade das experiências dos usuários e enfatiza princípios como respeito à dignidade, escuta ativa, comunicação empática e compartilhamento de decisões, sendo referência internacional na promoção do cuidado centrado no paciente como componente estruturante da qualidade do atendimento (Nice, 2012). Além disso, ressalta a importância da continuidade do cuidado e da comunicação aberta e colaborativa ao fortalecimento da aliança terapêutica, reduzindo barreiras na adesão ao tratamento e promovendo melhor manejo da dor (Lipkin *et al.*, 1995). O estudo também aponta que a comunicação inadequada de resultados negativos de exames pode gerar frustração e comprometer a relação médico-paciente, evidenciando a necessidade de estratégias mais humanizadas na abordagem clínica (Nice, 2021).

Dessa forma, a comunicação eficaz fortalece a relação terapêutica, contribui para a compreensão do quadro clínico e melhora a experiência do paciente no cuidado em saúde. Para isso, os profissionais devem adotar uma postura centrada no paciente (Ferla *et al.*, 2023) e estabelecer um vínculo interpessoal, valendo-se de

estratégias não verbais (Byrne; Heath, 1980) e verbais baseadas em evidências, como a escuta ativa, o questionamento aberto e reflexivo, a paráfrase e a tranquilização cognitiva e afetiva. Essas abordagens garantem que os pacientes se sintam ouvidos, compreendidos e engajados no processo terapêutico, resultando em maior adesão às orientações e na melhora do bem-estar (Xue; Heffernan, 2021).

Esta cartilha apresenta exemplos práticos de técnicas e estratégias que promovem a comunicação centrada no paciente, a qual é, ao mesmo tempo, empática e efetiva. Não se trata de um curso teórico sobre comunicação, mas de um material aplicado ao cotidiano dos profissionais de nível superior da APS – médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas. Algumas das estratégias descritas compartilham princípios conceituais e práticos, como a escuta ativa, que pode ser demonstrada por meio da paráfrase das falas do paciente.

A seguir, serão apresentadas recomendações para aprimorar a comunicação no atendimento a pacientes com dor crônica, fortalecendo o vínculo terapêutico e tornando o cuidado mais acolhedor e humanizado.



1. Escuta ativa e qualificada



Fazer uma escuta ativa e qualificada dos relatos do paciente significa estar presente e focado, afastando julgamentos, interrupções ou distrações.

Isso envolve prestar atenção à linguagem verbal e não verbal do paciente, demonstrar interesse e empatia, fazer perguntas abertas para entender melhor as suas preocupações e permitir que o paciente compartilhe suas experiências e sentimentos (NICE, 2021). Além disso, é essencial validar e compreender as falas do paciente, reafirmando e legitimando as suas preocupações e emoções (Hotta *et al.*, 2022; Weger *et al.*, 2014). Essas atitudes ajudam a estabelecer um relacionamento de confiança e respeito com o paciente, facilitando, assim, a comunicação efetiva e a tomada de decisões compartilhada.



1. Escuta ativa e qualificada

NA PRÁTICA, VOCÊ DEVE:

1



Fazer **contato visual** frequente e **demonstrar interesse** no que o paciente está dizendo;

2



Refletir as emoções do paciente, para **evidenciar que você está entendendo como ele se sente**;

3



Fazer **perguntas abertas**, a fim de que o paciente expresse suas preocupações ou ideias livremente;

4



Repetir o que o paciente acabou de dizer, para **verificar se você entendeu corretamente**;

5



Evitar **interromper o paciente** enquanto está falando;

6



Parafrasear as informações compartilhadas pelo paciente para **mostrar que você está acompanhando a narrativa**;

7



Demonstrar empatia e validar as preocupações do paciente.



2. Linguagem acessível



A comunicação efetiva e centrada no paciente refere-se, ainda, ao uso da **comunicação clara, compreensível e adaptada ao nível de entendimento, contexto sociocultural e necessidades do paciente**. Isso significa evitar jargões técnicos ou termos complexos, utilizando, portanto, palavras simples, frases curtas e explicações diretas (Danaher *et al.*, 2023).

Além disso, esse processo **envolve o uso de recursos visuais, metáforas ou exemplos práticos, quando necessários, garantindo que o paciente compreenda plenamente as informações sobre a sua saúde e tratamento**.



O objetivo é promover um diálogo participativo, no qual o paciente se sinta seguro, informado e capaz de tomar decisões sobre seu próprio cuidado e de compartilhar dúvidas e anseios.



2. Linguagem acessível

NA PRÁTICA, VOCÊ DEVE:

Evitar jargões técnicos e usar termos simples e de fácil entendimento;

1

Verificar se o paciente compreendeu, de fato, as informações fornecidas fazendo perguntas como "Você está acompanhando o que estou dizendo?" ou "Você tem alguma dúvida sobre o que eu acabei de explicar?";

2

Utilizar exemplos e analogias para ilustrar conceitos mais complexos, evitando o nocebo;

3

Adaptar a linguagem e o ritmo da fala ao nível de compreensão do paciente;

4

Encorajar o paciente a fazer perguntas ou a pedir esclarecimentos, garantindo que ele se sinta à vontade para expor suas dúvidas;

5

Usar recursos visuais, como desenhos ou gráficos simples, que ajudem a explicar informações mais complexas;

6

Fornecer material educativo por escrito, como folhetos ou cartilhas, para que o paciente possa revisar as informações em casa.

7



3. Perguntas abertas



Fazer perguntas que incentivem o paciente a fornecer informações mais detalhadas sobre as suas preocupações e necessidades é uma prática importante.

Para incluir perguntas abertas na comunicação com o paciente, você deve enfatizar a importância de ouvir a sua história completa, sem pressuposições, de modo a permitir a livre expressão do indivíduo (Rollnick; Miller; Butler, 2008). Durante a conversa, você pode utilizar frases como "Conte-me mais sobre isso" ou "Como você se sente em relação a isso?" a fim de encorajar o paciente a falar mais sobre a sua condição, preocupações e preferências.

Outra maneira de assegurar que utilizou perguntas abertas é resumir e recapitular as informações fornecidas pelo paciente e, em seguida, solicitar *feedback* para verificar se entendeu corretamente.

Na prática, você pode usar algumas das sugestões de perguntas abertas a seguir, as quais auxiliam o diálogo com o paciente no contexto da queixa de dor.

1. Como você descreveria a sua dor atual e como isso afeta a sua vida diária?

2. O que você já sabe sobre o funcionamento da dor em seu corpo?

3. Como você acha que a dor está relacionada com o funcionamento dos seus nervos e músculos?

4. O que você acha que contribui ou afeta a sua dor crônica musculoesquelética?

5. Você tem alguma dúvida sobre como a dor crônica funciona e como podemos aliviá-la?

6. Como você acha que podemos trabalhar juntos para ajudar a reduzir a dor crônica?

7. Quais atividades você acha que causam ou pioram a sua dor crônica?

8. Como você se sente sobre a perspectiva de mudar seus hábitos para reduzir a dor crônica?

9. Você tem alguma ideia de como podemos abordar a sua dor crônica de forma mais eficaz?

10. O que você espera alcançar ao trabalharmos juntos para gerenciar sua dor crônica?



4. Parafrasear



Parafrasear significa reformular, em suas próprias palavras, o que o paciente expressou, mantendo o significado original. Esse recurso demonstra escuta ativa, valida a experiência do paciente e garante que a mensagem foi compreendida corretamente (Barros; Botazzo, 2011; Rollnick; Miller; Butler, 2008).

Além disso, ajuda a esclarecer dúvidas, reduzir ambiguidades e fortalecer a relação terapêutica. Por exemplo, **se um paciente diz: "Sinto uma dor constante no ombro que piora quando levanto o braço", o profissional pode parafrasear: "Então, você sente uma dor contínua no ombro, que se intensifica ao realizar movimentos de elevação. Entendi corretamente?"**. Isso incentiva o paciente a aprofundar sua fala e melhora a comunicação clínica.

A seguir, cita-se algumas maneiras práticas de demonstrar que você está usando a estratégia de parafrasear durante a comunicação com o paciente.

Na prática, você pode incluir:

1. Repetir as palavras do paciente, parafraseando-as em seguida, para ter certeza de que você entendeu corretamente o que foi dito. Por exemplo:
"Então, se eu entendi bem, você está dizendo que a dor piora quando você faz movimentos bruscos, certo?"

2. Resumir a história do paciente em suas próprias palavras e pedir-lhe que confirme se você o entendeu corretamente. Por exemplo:
"Pelo que eu entendi, você está com dor crônica na região lombar há alguns meses. A dor aumenta quando você faz esforço físico e diminui quando você fica em repouso, é isso mesmo?"

3. Refletir sobre as emoções do paciente e parafrasear seus sentimentos. Por exemplo: "Parece que você está se sentindo frustrado com a dor que tem sentido há tanto tempo. Isso é certo?"



5. Tranquilização cognitiva



No âmbito da comunicação efetiva e centrada no paciente com dor, trata-se da oferta de informações claras e baseadas em evidências para reduzir a incerteza e o medo do paciente em relação à sua condição.

Isso envolve explicar a natureza da dor, diferenciar sinais de alerta de dor crônica benigna, desmistificar crenças negativas e reforçar a segurança do tratamento (Hasenbring; Pincus, 2015; Pincus *et al.*, 2013). Por exemplo, um profissional pode dizer: "Sei que essa dor tem sido preocupante para você, mas os exames não indicam nenhuma lesão grave. Isso significa que, com o tratamento adequado e o movimento controlado, você pode melhorar a sua condição de saúde, sem risco a danos."

Esse tipo de comunicação ajuda o paciente a compreender melhor a sua condição, reduzindo a catastrofização e promovendo maior confiança no processo de cuidado. **A tranquilização cognitiva não se trata apenas de dar informações epidemiológicas ou de prognóstico. Portanto, a seguir, você verá uma lista de opções práticas para essas situações.**



5. Tranquilização cognitiva

1

Identificar as preocupações específicas do paciente e validá-las: pergunte ao paciente sobre as principais preocupações em relação à sua condição de saúde e ouça atentamente a resposta.

Em seguida, valide suas preocupações, dizendo algo como: "**Compreendo como isso pode ser assustador/estressante/preocupante para você.**"

2

Explicar as informações de maneira clara e acessível: use uma linguagem simples e evite termos técnicos para garantir que o paciente entenda a informação que você está fornecendo.

É importante comunicar informações precisas e corretas sobre a condição de saúde do paciente para ajudá-lo a entender a natureza de sua dor.

3

Oferecer opções e encorajar a tomada de decisão compartilhada: pergunte ao paciente sobre as suas preferências e ofereça opções para o tratamento. Encoraje o paciente a tomar decisões informadas e a ser parte ativa do processo de tratamento.

4

Reforçar as habilidades de enfrentamento do paciente: ajude-o a identificar as suas próprias habilidades de enfrentamento e incentive-o a usá-las. Reforce suas habilidades positivas, auxiliando-o a desenvolver novas estratégias para enfrentar sua dor.

5

Incentivar uma atitude positiva: encoraje o paciente a ter uma atitude positiva em relação ao tratamento e seu processo de recuperação. Reforce a ideia de que a dor pode ser gerenciada e que o paciente tem o poder de melhorar a sua qualidade de vida.



6. Tranquilização afetiva



Tranquilização ou *reassurance* afetiva refere-se à validação e ao acolhimento das emoções do paciente, demonstrando empatia, apoio e compreensão ou mesmo compaixão pelo sofrimento do paciente.

A *reassurance* afetiva é uma estratégia que visa oferecer conforto e apoio emocional ao paciente, sendo fundamental em situações de dor crônica ou de longa duração, em que a dor pode afetar o bem-estar psicológico do paciente (Hasenbring; Pincus, 2015; Pincus *et al.*, 2013). Isso envolve reconhecer o impacto da dor na vida do paciente, validar suas preocupações e oferecer conforto emocional, criando um ambiente de confiança e segurança. Por exemplo, um profissional pode dizer:

"Eu entendo que essa dor tem sido muito difícil para você. É natural se sentir frustrado, mas estamos aqui para ajudar e encontrar formas de melhorar a sua qualidade de vida."

Esse tipo de comunicação **fortalece a relação terapêutica, reduz a ansiedade e melhora a experiência do paciente no cuidado à saúde.**

Há formas de incluir *reassurance* afetiva, as quais são verbais e não verbais. Veja exemplos práticos a seguir.



6. Tranquilização afetiva

1

Utilizar expressões verbais que transmitem empatia e cuidado, como **"Eu entendo como você está se sentindo."** ou **"Sinto muito que você esteja passando por isso."**

2

Usar toques suaves ou gestos que possam **transmitir conforto e acolhimento, como colocar a mão no ombro do paciente ou oferecer um lenço de papel, se necessário.**

3

Ser receptivo às emoções que o paciente expressa, validando-as e ajudando-o a lidar com essas sensações, com frases como **"É normal se sentir assim, mas vamos trabalhar juntos para encontrar maneiras de aliviar essa dor."**

4

Fornecer informações positivas e encorajadoras, **destacando as possibilidades de melhora e os recursos disponíveis para lidar com a dor.**



7. *Rapport*



No contexto da comunicação efetiva e centrada no paciente com dor, o *rapport* refere-se ao estabelecimento de uma conexão baseada na confiança, respeito e empatia entre profissional de saúde e paciente.

Esse vínculo ajuda o paciente a sentir-se mais à vontade para discutir suas preocupações, compartilhar informações relevantes sobre a sua saúde e seguir as orientações recebidas. O termo *rapport*, de origem francesa, significa "relação" ou "contato" e foi incorporado ao inglês para descrever a harmonia e a empatia estabelecidas entre duas pessoas. O conceito vem dos campos da psicologia e da comunicação e foi amplamente explorado por Carl Rogers, psicólogo humanista. Em sua abordagem centrada na pessoa, Rogers enfatizou que empatia, congruência (autenticidade) e aceitação incondicional são essenciais para criar conexões significativas — elementos fundamentais para o desenvolvimento do *rapport* (Rogers, 1977).

Essa técnica pode ser aplicada de diversas formas, incluindo o uso da linguagem corporal, tom de voz, escolha das palavras, demonstração de respeito e empatia. Construir e manter o *rapport* exige tempo, esforço e uma abordagem individualizada para cada paciente. **Quando bem estabelecido, favorece a adesão ao tratamento e contribui para melhores resultados em saúde (Mankelow *et al.*, 2022).**



7. *Rapport*

1

Mostrar interesse genuíno na vida do paciente, fazendo perguntas abertas sobre seus *hobbies*, trabalho, família, entre outros aspectos.

2

Usar uma linguagem corporal aberta e receptiva, incluindo contato visual, postura relaxada e sorrisos frequentes.

3

Usar tom de voz amigável e empático.

4

Validar as emoções do paciente e mostrar empatia em relação às suas experiências e aos seus sentimentos.

5

Encontrar pontos em comum entre você e o paciente, a fim de que se façam conexões com base nessas afinidades.

6

Ser autêntico e transparente em sua comunicação, evitando falsidades ou manipulação.

7

Assumir uma postura e expressão de emoções semelhantes às do paciente, sendo isso conhecido como espelhamento corporal e emocional.



8. Tomada de decisão compartilhada



A tomada de decisão compartilhada é um processo colaborativo em que o profissional de saúde e o paciente trabalham juntos para escolher a melhor abordagem terapêutica, considerando as opções disponíveis, as evidências científicas e as preferências, valores e necessidades individuais do paciente.

No contexto do cuidado à dor crônica, esse modelo reforça a autonomia do paciente e contribui para maior engajamento no tratamento, impactando positivamente na adesão e nos desfechos clínicos. A comunicação eficaz desempenha um papel fundamental nesse processo, garantindo que o paciente compreenda as opções terapêuticas, os potenciais benefícios e riscos, bem como se sinta seguro para expressar suas expectativas e preocupações.

A tomada de decisão compartilhada não se limita a fornecer informações: trata-se de criar um ambiente de diálogo aberto e respeitoso, por meio do qual a decisão é construída conjuntamente, com base na melhor evidência disponível e na experiência clínica, sempre alinhada às necessidades individuais do paciente (Belton; Birkinshaw; Pincus, 2022; Haverfield *et al.*, 2018). Ao aplicar essa abordagem, os profissionais da APS fortalecem a relação terapêutica e promovem o cuidado mais humanizado e centrado no paciente, respeitando sua participação ativa no processo decisório e contribuindo para melhores resultados em saúde.

O processo de tomada de decisão compartilhada é, de fato, uma “filosofia” de trabalho. Aqui, serão destacadas estratégias de comunicação que podem auxiliar esse processo.



8. Tomada de decisão compartilhada

NA PRÁTICA, VOCÊ DEVE:

Explicar as opções de tratamento disponíveis para o paciente e os respectivos prós e contras.

1

Considerar as preocupações e expectativas do paciente em relação ao tratamento.

4

Fazer perguntas abertas para entender as preferências e valores do paciente em relação ao tratamento.

2

Facilitar uma discussão em que o paciente possa expressar as suas preferências e tomar uma decisão informada sobre o tratamento.

5

Explicar as evidências científicas disponíveis para cada opção de tratamento e discutir como podem ser aplicadas naquele caso em específico.

3



9. Perguntas reflexivas



Usar perguntas reflexivas é uma estratégia de comunicação que estimula o paciente a analisar e expressar seus pensamentos, sentimentos e expectativas em relação à sua condição e ao seu tratamento.

Diferentemente das perguntas diretas ou fechadas, que buscam respostas objetivas, as perguntas reflexivas incentivam a introspecção e a construção ativa do significado da experiência vivida pelo paciente (Rollnick; Miller; Butler, 2008).

No contexto do cuidado à dor crônica, esse tipo de pergunta ajuda a promover um diálogo mais profundo e colaborativo, permitindo que o paciente compreenda melhor seu próprio papel no tratamento e desenvolva maior autonomia nas decisões sobre sua saúde. Além disso, facilita a identificação de barreiras emocionais e práticas que possam interferir na adesão ao tratamento, possibilitando uma abordagem mais personalizada e eficaz.

Ao incorporar perguntas reflexivas na comunicação clínica, os profissionais da APS criam um **ambiente mais acolhedor e um diálogo mais significativo e colaborativo com o paciente, incentivando-o a refletir sobre seus próprios objetivos e motivações em relação ao seu tratamento e cuidados de saúde.**



9. Perguntas reflexivas

Para incluir perguntas reflexivas na comunicação com o paciente, você pode tentar trazer questionamentos que o incentivem a refletir e explorar seus próprios pensamentos e sentimentos sobre a sua condição, tratamento e objetivos de saúde. A seguir, cita-se alguns exemplos de perguntas reflexivas.

1. Como você se sente sobre essa opção de tratamento?

2. Quais são as suas preocupações em relação a este plano de cuidados?

3. O que você espera alcançar com o tratamento?

4. Como você vê a sua participação no cuidado com a saúde?

5. O que você acha que poderia fazer para melhorar sua condição?

6. Que aspectos da sua vida seriam diferentes se você não tivesse essa condição?

7. Como você acha que seria sua vida se pudessemos melhorar apenas em parte a sua condição?

Essas são apenas algumas das muitas técnicas e estratégias que podem ser usadas para uma comunicação centrada no paciente. É importante lembrar que cada paciente é único e pode ter necessidades diferentes; portanto, é importante adaptar a sua comunicação a fim de atender plenamente as necessidades individuais de cada paciente.

A comunicação eficaz na área da saúde é essencial para construir relacionamentos terapêuticos fortes, entender o quadro clínico e melhorar a experiência do paciente. Treinar profissionais de saúde em habilidades de comunicação é fundamental para atingir esses resultados, levando, em última análise, a melhores resultados de saúde e à satisfação do paciente.



Conclusão

Comunicação como Pilar do Cuidado na Dor Crônica

A comunicação efetiva e empática é um dos pilares do cuidado à dor crônica na APS. Como profissional de saúde, você desempenha um papel fundamental na construção de um ambiente acolhedor e de confiança, no qual o paciente se sente ouvido, compreendido e valorizado.



Conclusão

Mais do que transmitir informações, comunicar-se bem significa **validar o sofrimento do paciente, promover expectativas positivas em relação ao tratamento e ajudar a compreender e se adaptar às novas realidades impostas pela dor, especialmente àquelas de mais difícil manejo.**

Pacientes com dor crônica frequentemente vivenciam frustrações, medos e inseguranças em relação à sua condição e à eficácia do tratamento. A maneira como você se comunica pode impactar diretamente na adesão ao cuidado e na evolução clínica do paciente. **Estratégias como escuta ativa, perguntas reflexivas, tranquilização cognitiva e afetiva e tomada de decisão compartilhada não são apenas técnicas, mas instrumentos poderosos para fortalecer a relação terapêutica e dar ao paciente um papel ativo no seu processo de cuidado.**

Para alcançar esses resultados, você deve adotar estratégias que promovam uma comunicação eficaz com pacientes que apresentam dor crônica. Isso inclui demonstrar validação e crença na experiência do paciente, utilizando escuta ativa e empatia para fortalecer a relação terapêutica.



Conclusão

A comunicação deve ser aberta, não julgadora e adaptada ao nível de compreensão do paciente, utilizando linguagem acessível e explicações detalhadas sobre diagnósticos e opções de tratamento.

Além disso, é fundamental garantir a continuidade do cuidado, evitando fragmentação da informação e assegurando que o paciente tenha um entendimento claro sobre seu quadro clínico e os passos seguintes no tratamento. O uso de materiais visuais, explicações sobre os impactos da dor no cotidiano e o incentivo ao autogerenciamento da condição também são práticas recomendadas (NICE, 2021).

É essencial reconhecer que a dor crônica nem sempre pode ser eliminada. No entanto, pode ser gerenciada de forma mais eficaz quando o paciente sente que faz parte do processo e que suas preocupações são levadas a sério. Seu compromisso com uma comunicação de qualidade não apenas melhora a satisfação do paciente, mas igualmente contribui para uma prática humana e resolutiva, uma vez que cada interação é uma oportunidade de fazer a diferença.

Ao aplicar as estratégias apresentadas nesta cartilha, você não apenas aprimora sua comunicação, mas também amplia as possibilidades de um cuidado mais compassivo e eficiente, promovendo maior qualidade de vida para aqueles que confiam em você para aliviar a sua dor.



Guia rápido

Como aplicar o
conhecimento sobre
comunicação efetiva
e empática ?



1. A Importância da Comunicação Empática

A comunicação eficaz não se resume a informar, mas a ouvir, validar e construir uma relação terapêutica baseada na confiança. **Pacientes que se sentem ouvidos apresentam melhor adesão ao tratamento e maior satisfação com o atendimento.**

Pergunta Reflexiva

"Você já se perguntou como suas palavras podem impactar o dia de um paciente?"



1. A Importância da Comunicação Empática

O que fazer?

Demonstrar interesse genuíno no relato do paciente.



Usar uma linguagem baseada em pontos fortes, respeitosa, inclusiva e que transmita esperança.



Usar linguagem neutra, sem julgamentos e baseada em fatos, ações ou fisiologia/biologia.



Criar um ambiente seguro para que o paciente possa expressar as suas preocupações.



Usar uma linguagem livre de estigma, que promova a colaboração entre pacientes e provedores.



Ajustar a linguagem para garantir que a informação seja compreendida.



O que evitar?

Interromper o paciente enquanto fala.



Minimizar sua queixa com frases como "Isso não é nada!"



Usar jargões técnicos que dificultam a compreensão.





Um guia rápido sobre como aplicar o conhecimento sobre Comunicação Efetiva e Empática

2. Estratégias fundamentais para melhorar a comunicação

Praticar a Escuta Ativa:

- Mantenha contato visual e demonstre interesse a partir de gestos ou acenos de cabeça;
- Evite interrupções, permitindo que o paciente conclua sua fala;
- Reformule o que foi dito pelo paciente a fim de garantir que compreendeu tudo corretamente.

Exemplo prático:

Paciente:

"Não aguento mais essa dor."

Profissional:

"Como isso tem afetado o seu dia a dia?"



Validar o sofrimento do paciente exige que você:

Reconheça o impacto da dor na vida do paciente;

Use frases como **"Entendo como isso pode ser difícil para você."**

Evite respostas que minimizam a experiência do paciente.



Evite dizer:

"Isso é normal."

"Todo mundo sente isso."

Em vez disso, utilize afirmações como:

"O que você está passando e sentindo é legítimo, e estou aqui para ajudar."



Um guia rápido sobre como aplicar o conhecimento sobre Comunicação Efetiva e Empática

2. Estratégias fundamentais para melhorar a comunicação

Adaptar a linguagem ao paciente:

- Use frases claras e objetivas, sem excesso de termos técnicos;
- Certifique-se sempre de que o paciente compreendeu a explicação fornecida;
- Diga: "Vamos trabalhar juntos para encontrar uma solução que funcione para você."

Exemplo
prático:

Não pergunte:
"Você sentiu dor ontem?"



Em vez disso, diga:
"Como foi sua dor ao longo do dia de ontem?"



Usar perguntas reflexivas:

Estimule o paciente a refletir sobre as suas percepções e expectativas.

"O que você espera alcançar com esse tratamento?"

Parafrasear para reforçar o entendimento:

Reformule as falas do paciente para confirmar compreensão.

"Então, se entendi corretamente, a dor piora ao final do dia?"

Oferecer tranquilização cognitiva e afetiva:

Explique o quadro clínico de forma clara e sem alarmismo. Valide as emoções do paciente e ofereça apoio.

"Essa dor pode ser controlada e estamos aqui para ajudá-lo com isso."



Um guia rápido sobre como aplicar o conhecimento sobre Comunicação Efetiva e Empática

3. Aplicando a Comunicação Empática na consulta

Início da consulta:
criando conexão

Durante a entrevista:
mantendo a escuta ativa

Encerramento da consulta:
construindo um plano terapêutico

✓ Exemplos de boas práticas

"Como você está se sentindo hoje?"

"Gostaria de entender melhor como a dor tem afetado a sua vida. Pode me contar mais?"

✓ Frases úteis

"Estou aqui para ouvir você. Fique à vontade para me contar tudo o que acha importante."

"Se precisar de uma pausa ou preferir retomar algum ponto, por favor, avise-me."

✓ Exemplos de frases eficazes

"Agradeço por compartilhar suas dificuldades. Isso me ajuda a entender como podemos tratar a sua dor."

"Foi um prazer ouvir você. Vamos trabalhar juntos para melhorar sua qualidade de vida."

✗ Erros comuns

Começar a consulta diretamente, a partir de perguntas técnicas e sem acolhimento inicial.

Evitar o contato visual enquanto o paciente fala.

✗ Erros comuns

Responder rapidamente, sem refletir sobre o que o paciente disse.

Pressupor que já sabe a resposta antes do paciente concluir.

✗ Erros comuns

Não perguntar ao paciente se tem dúvidas ou algo a acrescentar.

Finalizar a consulta de forma apressada, sem reforçar a parceria no tratamento.



4. Quadro sobre o que é certo e o que é errado na Comunicação Empática

Evite



"Isso não é nada sério."

"Você deveria apenas relaxar."

"Todo mundo sente isso."

"Você precisa ser mais forte."

Prefira



"Entendo que essa dor tem impactado a sua vida."

"Podemos buscar estratégias para aliviar essa tensão."

"Cada pessoa tem uma experiência única com a dor."

"Sei que lidar com a dor pode ser difícil. Por isso, vamos conversar sobre isso."



5. Conclusão: comunicação é cuidado

Comunicar com empatia é tratar além da dor. Cada consulta é uma oportunidade de fortalecer o vínculo terapêutico e tornar o cuidado mais humano e efetivo.



Dica extra

Pequenas mudanças na comunicação diária fazem toda a diferença! Pratique isso simulando um paciente com seus companheiros de trabalho. Aplique essas técnicas e observe como podem transformar o atendimento.



Esta cartilha foi desenvolvida para profissionais da Atenção Primária, oferecendo diretrizes práticas para aprimorar a comunicação com os pacientes e fortalecer a relação terapêutica.



Referências

BARROS, R. S. DE; BOTAZZO, C. Subjetividade e clínica na atenção básica: narrativas, histórias de vida e construção de sentido. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 16, n. 11, p. 4337-4348, 2011. Disponível em:

<https://doi.org/10.1590/S1413-81232011001200006>. Acesso em: 15 mar. 2025.

BELTON, J.; BIRKINSHAW, H.; PINCUS, T. Patient-centered consultations for persons with musculoskeletal conditions. **Chiropractic & Manual Therapies**, v. 30, n. 1, p. 53, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12998-022-00466-w>. Acesso em: 15 mar. 2025.

BYRNE, P. S.; HEATH, C. C. Practitioners' use of non-verbal behaviour in real consultations. **The Journal of the Royal College of General Practitioners**, v. 30, n. 215, p. 327-331, 1980.

CLIFF, B. The evolution of patient-centered care. **Journal of Healthcare Management: American College of Healthcare Executives**, v. 57, n. 2, p. 86-88, 2012.

DANAHER, T. S., *et al.* Improving how clinicians communicate with patients: an integrative review and framework. **Journal of Service Research**, v. 26, n. 4, p. 493-510, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/10946705231190018>. Acesso em: 15 mar. 2025.

FERLA, J. B. D. S. *et al.* Patient-centered care - evidence in the context of professional health practice. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 76, n. 5, e20220448, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2022-0448>. Acesso em: 15 mar. 2025.

GUAN, T. E. Moving forward in patient-centred care. **Proceedings of Singapore Healthcare**, v. 20, n. 2, p. 69-70, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/201010581102000201>. Acesso em: 15 mar. 2025.

HASENBRING, M. I.; PINCUS, T. Effective reassurance in primary care of low back pain: what messages from clinicians are most beneficial at early stages? **The Clinical Journal of Pain**, v. 31, n. 2, p. 133-136, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1097/AJP.0000000000000097>. Acesso em: 15 mar. 2025.

HAVERFIELD, M. C. *et al.* Patient-centered pain management communication from the patient perspective. **Journal of General Internal Medicine**, v. 33, p. 1374-1380, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11606-018-4490-y>. Acesso em: 15 mar. 2025.

HOTTA, G. H. *et al.* Therapeutic approach to pain-related fear and avoidance in adults with chronic musculoskeletal pain: an integrative review and a roadmap for clinicians. **BrJP**, v. 5, n. 1, p. 72-79, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/2595-0118.20220015>. Acesso em: 15 mar. 2025.

LIPKIN, M. *et al.* (Ed.). **The medical interview: clinical care, education, and research**. New York: Springer-Verlag, 1995.

MANKELOW, J. *et al.* An exploration of primary care healthcare professionals' understanding of pain and pain management following a brief pain science education. **BMC Medical Education**, v. 22, n. 1, p. 211, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12909-022-03265-2>. Acesso em: 15 mar. 2025.

NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND CARE EXCELLENCE (NICE). **Chronic pain (primary and secondary) in over 16s: assessment of all chronic pain and management of chronic primary pain** (NG193). London: NICE, 2021. Disponível em: <https://www.nice.org.uk/guidance/ng193/chapter/Recommendations#assessing-all-types-of-chronic-pain-chronic-primary-pain-chronic-secondary-pain-or-both>. Acesso em: 15 mar. 2025.

NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND CARE EXCELLENCE (NICE). **Patient experience in adult NHS services: improving the experience of care for people using adult NHS services** (CG138). London: NICE, 2012. Disponível em: <https://www.nice.org.uk/guidance/cg138>. Acesso em: 13 abr. 2025.

PINCUS, T. *et al.* Cognitive and affective reassurance and patient outcomes in primary care: a systematic review. **Pain**, v. 154, n. 11, p. 2407-2416, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.pain.2013.07.019>. Acesso em: 15 mar. 2025.

ROGERS, C. R. **Tornar-se pessoa**. São Paulo: Martins Fontes, 1977.

ROLLNICK, S.; MILLER, W. R.; BUTLER, C. C. **Motivational interviewing in health care: helping patients change behavior**. New York: Guilford Press, 2008.

SILVA, C. F. *et al.* Patient-centered care. In: SILVA, C. *et al.* (Ed.). **Value-based radiology**. Cham: Springer, 2019. (Medical Radiology). Disponível em: https://doi.org/10.1007/174_2019_209. Acesso em: 15 mar. 2025.

STEWART, M. Towards a global definition of patient centred care. **BMJ: British Medical Journal**, v. 322, n. 7284, p. 444-445, 2001. Disponível em: <https://doi.org/10.1136/bmj.322.7284.444>. Acesso em: 15 mar. 2025.

WEGER, H. *et al.* The relative effectiveness of active listening in initial interactions. **International Journal of Listening**, v. 28, n. 1, p. 13-31, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/10904018.2013.813234>. Acesso em: 15 mar. 2025.

XUE, W.; HEFFERNAN, C. Therapeutic communication within the nurse-patient relationship: A concept analysis. **International Journal of Nursing Practice**, v. 27, n. 6, e12938, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/ijn.12938>. Acesso em: 15 mar. 2025.

Ficha técnica

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Secretaria de Atenção Primária à Saúde - SAPS
Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde - DEPPROS
Núcleo Técnico de Gestão da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS - NTG PNPIC.

Angela Fernandes Leal da Silva – Diretora do Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde – DEPPROS.

Paulo Roberto Sousa Rocha – Coordenação Geral e Referência Técnica para a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS – NTG PNPIC/DEPPROS/SAPS/MS.

Daniel Miele Amado – Referência Técnica para a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS – NTG PNPIC/DEPPROS/SAPS/MS.

Nathalia Oliveira da Silva – Assessora Técnica no Núcleo Técnico de Gestão da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS – NTG PNPIC/DEPPROS/SAPS/MS.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Reitoria
Ursula Rosa da Silva

Vice-Reitoria
Eraldo dos Santos Pinheiro

Coordenação Geral
Julieta Carriconde Fripp – Coordenadora da Cuidativa (Centro Regional de Referência em Cuidados Paliativos FAMED/UFPEL), Diretora da Faculdade de Medicina da UFPEL.

Coordenadora Adjunta
Simone da Fonseca Sanghi – Assistente Social da Cuidativa (Centro Regional de Referência em Cuidados Paliativos FAMED/UFPEL), Colaboradora dos processos de Gestão na Cuidativa.

Ficha técnica

CRÉDITOS DO CURSO

Coordenação Geral

Paulo Roberto Sousa Rocha
Julieta Carriconde Fripp
Simone da Fonseca Sanghi

Apoio Administrativo / Secretaria

Luciano Avila dos Santos

Coordenação de Conteúdo

Amirah Adnan Salman
Bárbara Cury Soubhia
Manuela Samir Maciel Salman

Consultoria e Revisão de Conteúdos

Amirah Adnan Salman
Andrea Cristina Lovato Ribeiro
Bárbara Cury Soubhia
Julieta Carriconde Fripp
Manuela Samir Maciel Salman
Nathalia Oliveira da Silva
Paulo Roberto Sousa Rocha
Simone da Fonseca Sanghi

Coordenação Pedagógica

Amirah Adnan Salman
Andrea Cristina Lovato Ribeiro
Bárbara Cury Soubhia
Manuela Samir Maciel Salman

Coordenação de Pesquisa e Relatórios

Luiz Augusto Facchini
Elaine Thumé
Elaine Tomasi

Coordenação de Mídias e Comunicação

Samir Salman
João Rocha Rodrigues
Luana Copini Jahn

Coordenação de Tecnologia e Informação

Alessander Osório

Coordenação da Produção

Alexandre Moretto Ribeiro
Andrea Cristina Lovato Ribeiro

Revisão Gramatical/Ortográfica e ABNT

Giulia M. Delazzeri

Produção Audiovisual

Eduardo Dias Abreu

Assistente de Produção Audiovisual

Luciana Melo

Animação

Márlon Lima

Ilustração

Mario Vitor Gouveia Cau

Diagramação e Design Gráfico

Daniele Rossi

Design Web e Programação

Vando Pinto

Conteúdo

Anamaria Siriani de Oliveira
Antonio Seixlack
Arthur Fernandes da Silva
Bernardo Diniz Coutinho
Débora Silva Teixeira
Fabianna Resende de Jesus Moraleida
Fernanda de Figueiredo Torres
Fernanda Martins Pereira Hildebrandt
Fernanda Pereira de Paula Freitas
Francinete Araujo
Josimari Melo de Santana
Juliana Marques Coelho Bastos
Marco Túlio Cária Guimarães Pereira
Marcos Lisboa Neves
Marcos Paulo Veloso Correia
Mariana Cabral Schweitzer
Milene Zanoni da Silva
Rodrigo Macedo Pacheco
Rui Ferreira Afonso
Sandra Fortes

CRÉDITOS DESTE RECURSO DIDÁTICO

Conteúdo

Anamaria Siriani de Oliveira